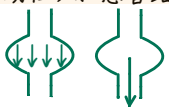
随课更新　配套anki　定期答疑　公众号小凯的医学之路　笔记为二次创作，版权为天天师兄所有

本质上是囊性扩张　胆汁蓄积(出现黄疸)→排走(黄疸消失)

2.右上腹痛（多为钝痛/胀痛）、右上腹肿块（多为表面光滑的囊性肿块）、**黄疸（呈间歇性蓄水池）**。80%在儿童期发病，10%癌变率　管道思维:梗阻点上方要有扩张

①先天性胆管扩张症一般都是儿童发病
②有20%的患者可能是成年发病

扩张 / 梗阻 / 扩张 — 只看到扩张,没有找到梗阻点,说明是先天性的



3.尽早手术

①**完全切除扩张的胆管+胆肠 RY 吻合**，合并局限性肝内胆管扩张者需**同时切除病变部分肝脏**　VS肝内胆管结石如果引起局部的肝脏出现病变需切除部分肝脏

②肝内胆管扩张病变累及全肝或已发生肝硬化需肝移植　弥漫性病变切肝脏会发生肝衰竭

专题串联 • 黄疸有没有 & 胆囊大不大

跨章节和学科、用核心串核心，以便将重要考点串联成网

ttsx	黄疸	胆囊增大	其它	主要治疗
胆囊结石	× 未堵胆管 Mirizzi 征√ 压迫伴行肝总管	× 胆囊大,肝内外胆管正常,无黄疸 胆囊梗阻、Mirizzi 征√	阵发性胆绞痛（右上腹痛+不黄）	LC：有症状、无症状但有指征（结石≥2-3、息肉≥1、慢性胆囊炎、瓷性胆囊、糖尿病、心肺功能障碍）123盖茨慢糖心
急性胆囊炎	多×	√且痛 （Murphy 征）	持续胆绞痛阵发加剧、发热、腹膜炎、胆囊壁＞4mm 比胆囊结石多	≤3 天急诊 LC ＞3 天急诊 PTGD 或胆囊造口，3 个月后 LC
胆囊癌	若不伴胆管梗阻×	可√	好发底、体部 DT in the house	手术
肝内胆管结石及炎症	多× 肝内胆管多	×	好发肝左外叶和右后叶，反复肝区胸背部闷胀痛	胆管切开取石或切除病变部分肝脏
肝外胆管结石及炎症	√且波动性 随炎症发作与控制	不讨论 可大:胆总管堵石头,胆汁下不来 不大:胆总管结石很多是胆囊结石掉下来 可缩小:慢性胆囊炎纤维化缩小	Charcot 征（胆绞痛+黄疸+寒战高热） 甚至 Reynolds 征（Charcot 征+休克+中枢抑制） 胰腺炎患者经B超证实石头嵌顿在胆总管开口(胆总管扩张超过1cm),在保守治疗后尽早ERCP	①结石≤3 枚且＜1cm：经十二指肠内镜取石 ②胆总管切开取石（十二指肠上段）+T 管引流 ③结石嵌顿在胆总管开口：内镜 Oddi 括约肌切开 EST+取石+ENBD ④胆总管远端狭窄致梗阻无法解除：胆肠吻合+切胆囊 ⑤AOSC：急诊解除梗阻降低压力（PTCD、ENBD、或胆总管切开减压+T 管引流）、同时抗休克（补平衡盐） 位置高更好
胆管癌	√且进行性 右上腹摸到又痛又大的胆囊:Murphy征 右上腹摸到大但无痛的胆囊:courvoisier征	上段：×甚至缩小 中下段：√且无痛 （courvoisier 征）	上段/肝门部多见 靠近肝门血供好	上段：切胆囊+肝外胆管（或+部分肝）+胆肠吻合 中段：切肿瘤+1cm 胆管+肝管空肠吻合 下段：Whipple 术或联合切除肝
胆管蛔虫	多×　e.g胰头癌、壶腹癌、十二指肠癌		阵发性钻顶样绞痛、突发突止、症征不符	保守为主
胆管闭锁	√且持续性		发育不良、苯巴比妥无效	尽量出生 2 个月内手术如 Kasai 等

胆石症并发症:胆道感染(胆囊/管炎)、肝脓肿、脓毒症、休克、胆道炎性狭窄、上消化道出血、癌变、胰腺炎、一般全选

穿孔 — 继发性腹膜炎 / …周围脓肿 / 瘘→胆石性肠梗阻

胆汁淤积性肝硬化 — 肝功不全 / 门脉高压 / 肝衰竭